Diskussion 764

Datum: 1935-06-06
Kammare: Första kammaren
Antal yttranden: 3
Källa: Tal om Kvinnor: Annotated Corpus (doi:10.5281/zenodo.18211787), byggd på The Swedish Parliament Corpus (Yrjänäinen m.fl. 2024).

Markerade ord: ¹ kvinna-ord, ² släktskaps- och tilltalsord, ³ yrkestitlar.

1. Alfred Petren (Socialdemokraterna, man)

Herr talman! I samband med det föreliggande förslaget om distriktsvårdens omorganisation, syftande till att denna efter viss övergångstid helt och hållet skulle handhavas av landstingen och inom densamma anställda **sköterskor³** i större utsträckning än hittills skulle ägna sig åt förebyggande hälsovård, har Kungl. Maj:t föreslagit sådan ändring i 36 $ hälsovårdsstadgan, att särskild hälsovårdsnämnd skall tillsättas för hälsovårdsområde med mera än 1,500 invånare, såframt icke medicinalstyrelsen på framställning av kommunalfullmäktige medger undantag.

Under det att det utskott, som har behandlat denna proposition, i vilket jag varit medlem, tillstyrkt förslaget om distriktsvårdens omorganisation, har utskottet däremot uttalat sig för den ändrade lydelse av Kungl. Maj:ts förslag beträffande hälsovårdsstadgans 36 $, att särskild hälsovårdsnämnd skall tillsättas för hälsovårdsområde med mer än 3,000 invånare. Jämte några andra medlemmar av utskottet i fråga har jag på denna punkt reserverat mig mot utskottets hemställan, då goda skäl synas mig vara anförda för Kungl. Maj:ts förslag att draga gränsen för skyldighet att utse hälsovårdsnämnd vid

Då Kungl. Maj:ts förslag således synes mig väl avvägt, har jag ej kunnat vara med om utskottets hemställan på den första punkten, utan yrkar, herr talman, bifall till Kungl. Maj:ts förslag om ändring av hälsovårdsstadgans 36 8:

2. Verner Andersson (Bondeförbundet, man)

Med den föreliggande propositionen ställes man inför ett omfattande utbyggande av en social anordning — jag tänker då närmast på den del av propositionen, som berör omorganisation av distriktsvården. Helt utbyggd enligt medicinalstyrelsens förslag med i genorasnitt en **sköters ka³** på 3,000 invånare, skulle denna vårdgren komma att kräva 1,400 distriktssköterskor, mot för närvarande 474 distriktssköterskor och 230 dispensärsköterskor. Härav torde framgå vilken omfattning denna organisation kommer att få. De uppgifter som komma att åvila dessa distriktssköterskor kunna uppdelas på huvudsakligen två grenar, dels en rörande socialhygien, dels en omfattande en mera sjukvårdande uppgift. I den förra uppgiften skulle bland annat även ingå en bostadsövervakning, varvid **sköterskan³** hade att till hälsovårdsnämnden eller provinsialläkaren avge rapport om bostadsförhållanden, speciellt sådana som kunde tarva ett ingripande från myndigheternas sida. Även om det kan föreligga behov av en sådan bostadsövervakning, vilket jag visst inte vill söka bestrida, vågar jag dock

starkt ifrågasätta, om det är så lämpligt att lägga denna uppgift i händerna just på distriktssköterskan. Det är en mycket grannlaga och ömtålig uppgift, och den kan lätt leda till misstro mot distriktssköterskan, till skada för **hennes²** uppgift i övrigt. Vidare skall det åligga distriktssköterskan att utöva en rådgivande och upplysande verksamhet i fråga om barnavård, och **hon²** kommer därvid att tangera uppgifter, som enligt mitt förmenande borde vara naturligare, att barnmorskorna omhänderhade. Jag är förvissad om att **mödrarna²** hellre vända sig till barnmorskorna i hithörande frågor för att få de råd och upplysningar, som kunna vara erforderliga. Därtill må framhållas att på grund av den sjunkande nativiteten barnmorskorna i många fall ha mycket litet att syssla med och följaktligen mycket väl hinna med denna uppgift. Distriktssköterskan skulle därjämte ägna sig åt direkt sjukvårdande uppgifter, som i huvudsak skulle bestå i utförande av sjukvård i hemmen. Medicinalstyrelsen har tydligen stora förväntningar på, att man med sådana möjligheter att tillgå i större utsträckning skall låta vårda de sjuka 1 hemmen. Jag ifrågasätter dock starkt, om denna förväntan kan komma att infrias. Det synes mig, som om erfarenheten ginge i den riktningen, att man i allt större utsträckning i vår tid anlitar anstalter och lasarett vid sjukdomsfall, vartill bidraga de möjligheter som nutida samfärdsmedel erbjuda

Vad slutligen gäller kostnaderna skulle dessa enligt propositionen uppgå till 3,164,000 kronor, därav staten skulle bidra med 1,540,000 kronor. Däri ingår emellertid ej kostnaden för resor för distriktssköterskorna, som säkerligen i de glest befolkade landskommunerna komma att uppgå till avsevärda belopp, då **sköterskorna³** ha att bedriva en omfattande fältverksamhet, vilket gör att de måste vara ute och röra på sig. Några anslag härtill eller anvisningar om vem som skall betala dessa resor är, såvitt Jag kan se, inte alls givna, och detta kanske kommer att leda därhän att distriktssköterskornas verksamhet i huvudsak kommer att omfatta mottagning och rådgivning i tjänstebostäderna. Man kan naturligtvis inte fordra att de själva skola bekosta sina tjänsteresor.

För Hallands landstingsområde kommer denna reform, om den skall genomföras enligt föreliggande direktiv, att kräva, i stället för som nu åtta distriktsoch fem dispensärsköterskor, 32 **sköterskor³** med en avsevärt ökad årlig kostnad. Jag tror icke att man inom detta landstingsområde kommer att hälsa denna reform med någon högre grad av tillfredsställelse. Då härtill kommer att inom medicinalstyrelsen pågår utarbetandet av förslag till omorganisation av dispensärvården, och frågorna rörande **mödraoch²** barnavård även inom en snar framtid komma att bli föremål för omprövning, då vi vidare redan ha distriktsvården reglerad enligt en lag så sent som 1920, vilken erbjuder såväl kommunerna som landstingen möjlighet att i den utsträckning som visar sig erforderlig anordna dylik vård, så synes det mig som om man skulle ha anledning att avvakta nämnda utrednings resultat. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till den av herrar Strindlund och Johansson avgivna reservationen.

3. Martin Svensson (–, man)

Den förste ärade talaren, professor Petrén, var inne på frågan om vilka kommuner som skulle vara skyldiga att inrätta särskild hälsovårdsnämnd. Utskottet har föreslagit att det skulle vara obligatoriskt för kommuner med över 3,000 invånare, medan reservanterna ha biträtt Kungl.

Maj:ts förslag, att skyldighet skall inträda, då en kommun har 1,500 invånare. Utskottsmajoriteten kan stödja sig på vad bostadssociala utredningen i det fallet har föreslagit; majoriteten inom denna utredning har nämligen föreslagit att gränsen skall sättas vid ett invånarantal av 3,000. Den förste ärade talaren nämnde, att det kunde ges dispens för kommuner som ha över 1.500 invånare men inte anse behövligt att inrätta särskild hälsovårdsnämnd. Det är dock förenat med ganska mycket besvär att få sådan dispens. Den skall beslutas av medicinalstyrelsen, och innan medicinalstyrelsen fattar ståndpunkt, skall länsstyrelsen höras. Jag tror att de kommuner det här gäller till övervägande del äro sådana som inte ha behov av särskild hälsovårdsnämnd.

Förslaget om ändring av hälsovårdsstadgan innebär ju, att inom kommunalnämnd som också är hälsovårdsnämnd skall finnas en särskild föredragande för hälsovårdsärenden, och därmed anser jag det vara tillräckligt sörjt för, att dessa få det beaktande som de förtjäna.

Den föregående talaren var inne på frågorna om bostadsinspektion, moderskapsvård och dispensärvård, och jag skall inte vidlyftigt uppehålla mig vid dessa, då jag förutsätter att den särskilt sakkunnige inom utskottet, professor Petrén. kommer att bemöta vad som anförts till stöd för avslagsyrkandet. Jag gick själv till behandlingen av detta ärende utan någon förutfattad mening, men under överläggningarna inom utskottet kom jag till den uppfattningen, att man utan någon större risk kan godtaga vad Kungl. Maj:t har föreslagit beträffande ordnande av bostadsinspektionen och dispensärvården.

Emellertid är jag reservant på en annan punkt, nämligen rörande storleken av statsbidraget till distriktsvården. Kungl. Maj:t har föreslagit att staten skall bidra med 1,000 kronor, medan landstinget skall bidra med 800 kronor. Ålderstillägg skola betalas av staten, och naturaförmåner, vilka i propositionen beräknas till 360 kronor per år, skola betalas av landstinget. I fråga om dessa kostnader har utskottet gjort några jämkningar i Kungl. Maj:ts förslag. I stället för två ålderstillägg har utskottet föreslagit tre, i stället för att ålderstilläggen skulle utgå efter 5 och 10 år har utskottet föreslagit att de skulle utgå efter 3, 6 och 9 år, varvid förmånen av fri tvätt och köksutrustning skulle kompenseras av det tredje ålderstillägget. Staten skulle härigenom få betala ett tredje ålderstillägg och landstingen få någon lindring i fråga om naturaförmånerna. Jag har dock ansett, att staten här bör sträcka sig något längre än vad Kungl. Maj:t och utskottsmajoriteten ha föreslagit. Som motiv för denna min ståndpunkt ber jag att få framhålla, att då staten på sätt och vis tvingar landstingen att gå in för denna distriktsvård, så kan man rimligtvis också begära, att staten bidrar kraftigare än vad som föreslagits. Tandstingen få ju nämligen en del kostnader, som inte äro fixerade i propositionen men som beröras i en motion av herr Thelin i första kammaren, nämligen vikariatsoch semesterarvoden till distriktssköterskorna samt kostnader för resor och för de ambulerande **sköterskor**[3], som herr Thelin i sin motion förutsätter i vissa fall bli erforderliga. Jag tror därför att det föreslagna bidraget av 1,000 kronor från staten är för litet. Man må ju också besinna, att åtskilliga landsting äro mycket hårt betungade av skatter, och dessa komma mer och mer att ökas genom de allt större krav som staten ställer

på landstingen. Den skatteutjämning, som skatteutjämningsberedningen förutsätter, tycks ju plockas sönder i smådelar, och där få inte landstingen den ersättning som man hade väntat, om beredningens förslag hade genomförts i sin helhet.

Vad återigen angår distriktens storlek, så ha där både Kungl. Maj:t och utskottet föreslagit en ganska stor frihet för landstingen, och jag vill uttala den förhoppningen, att när medicinalstyrelsen går att pröva planer från landstingen, den tar hänsyn till, att något visst invånarantal inte behöver fastställas. Siffran 3,000 invånare har ju visserligen nämnts som ett normaltal, men särskilt under första tiden, innan denna distriktsvård hinner tränga igenom, tror jag man får gå ut ifrån att distrikten bli större än vad som har tänkts av Kungl. Maj:t.

Jag skall be att få yrka bifall till utskottets utlåtande med den ändring att första punkten överst på sid. 16 får följande lydelse: »Utskottet har även ansett sig böra tillstyrka den i motionerna I: 305 och II: 532 föreslagna höjningen av statsbidraget från 1,000 till 1:200 kronor.»

I herr Martin Svenssons yttrande instämde herrar Thelin, von Geijer och Anders Andersson.